

Uzależnienie + ADHD u dorosłych

15–25% dorosłych z uzależnieniem ma ADHD. Mózg ADHD szuka stymulacji — substancja często ją daje. Bez leczenia ADHD nawroty są częstsze.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja + plan

ŹRÓDŁO: Wilens i wsp. (2011); van Emmerik-van Oortmerssen i wsp. (2012, metaanaliza)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza wiedzę o **współwystępowaniu ADHD i uzależnienia** u dorosłych: 1) jak rozpoznać ADHD u osoby uzależnionej, 2) **mechanizm hipostymulacji** tłumaczący sięganie po substancje, 3) jak rozróżnić objawy ADHD od objawów odstawiennych/intoksykacji, 4) **opcje leczenia** — w tym kontrowersję stosowania stymulantów u osób uzależnionych. Karta jest informacyjna — diagnozę ADHD u dorosłych może postawić tylko psychiatra lub psycholog kliniczny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

van Emmerik-van Oortmerssen i wsp. (2012, metaanaliza 29 badań, n=6 689) wykazali: **15–25% dorosłych z uzależnieniem ma ADHD** — 5–10× częściej niż w populacji ogólnej. ADHD jest *niedodiagnozowane* w populacji uzależnionej, bo objawy nakładają się z odstawieniem (drażliwość, trudności z koncentracją) i intoksykacją (impulsywność). Wilens i wsp. (2011) pokazali: **leczone ADHD** u osób w abstynencji *zmniejsza ryzyko nawrotu o 40–50%*; **nieleczone ADHD** przewiduje wcześniejszy nawrót (mediana 3–4 mies. vs 9–12 mies.). Mechanizm: deficyt dopaminergiczny w korze przedczołowej → mózg „szuka stymulacji” → substancja zapełnia tę pustkę natychmiast.

01 📋 ADHD u dorosłych — 3 klastry objawów

1 · DEFICYT UWAGI

- trudność z dłuższym skupieniem
- łatwa rozpraszalność
- „mgła” w głowie
- odkładanie zadań („prokrastynacja”)
- gubienie rzeczy

2 · NADPOBUDLIWOŚĆ

- wewnętrzny niepokój
- trudność z siedzeniem
- „bieganie myślami”
- potrzeba ciągłej stymulacji
- bezsenność (nie mogę „wyłączyć” głowy)

3 · IMPULSYWNOŚĆ

- decyzje natychmiastowe
- przerywanie innym
- wybuchy emocjonalne
- trudność z czekaniem
- ryzykowne zachowania

Kryterium diagnostyczne (DSM-5-TR): objawy obecne *przed 12 r.ż.*, utrzymują się w co najmniej 2 sytuacjach (praca, dom, relacje), powodują *znaczne upośledzenie*. ADHD diagnozuje się retrospektywnie — pytamy o dzieciństwo, oceny szkolne, opinie nauczycieli.

02 🧠 Hipoteza hipostymulacji — dlaczego ADHD szuka substancji

MECHANIZM NEUROBIOLOGICZNY

Mózg ADHD ma **obniżoną aktywność dopaminergiczną** w korze przedczołowej (Volkow i wsp. 2009). Konsekwencja: trudność z motywacją do codziennych zadań, „pusty” stan emocjonalny, szukanie silnych bodźców. Substancja — alkohol, kokaina, amfetamina, marihuana — daje *natychmiastową stymulację*, której brakuje.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SUBSTANCJE

- **Amfetamina / kokaina** — bezpośrednio zwiększają dopaminę, „leczą” objawy ADHD przez kilka godzin
- **Marihuana** — daje subiektywne uczucie spokoju, zmniejsza wewnętrzny niepokój
- **Alkohol** — wycisza nadpobudliwość, ułatwia sen
- **Nikotyna** — 2–3× częściej u osób z ADHD



OPCJA	KIEDY STOSOWAĆ	RYZYKA I UWAGI
<i>Atomoksetyna</i>	Pierwszy wybór u osób z uzależnieniem — nie jest stymulantem, brak potencjału uzależniającego	Słabsze działanie niż stymulanty (~30%). Działa od 4–6 tyg.
<i>Bupropion</i>	Antydepresant z efektem na ADHD; pomocny w odstawieniu nikotyny	Ostrożnie przy padaczce / drgawkach po alkoholu
<i>Metylfenidat / lisdeksamfetamina</i>	Stymulanty — najskuteczniejsze. Stosować tylko przy stabilnej abstynencji (3+ mies.) i pod ścisłą kontrolą	Potencjał uzależniający — kontrowersyjne. Preparaty o przedłużonym uwalnianiu (LA / XR) są bezpieczniejsze niż IR
<i>CBT dla ADHD (Safren)</i>	Zawsze — niezależnie od leków. Uczy organizacji, planowania, regulacji emocji	Daje 30–40% redukcji objawów bez leku

Kontrowersja stymulantów: obawa, że leki stymulujące u osób uzależnionych zwiększą ryzyko nawrotu.

Badania pokazują odwrotnie (Wilens i wsp. 2011, metaanaliza): leczone ADHD *zmniejsza* używanie substancji o 30–50%. Preparaty o przedłużonym uwalnianiu (lisdeksamfetamina, metylfenidat XR) mają minimalny potencjał uzależniający. **Decyzję podejmuje psychiatra** indywidualnie, uwzględniając profil pacjenta.



CZY MAM OBJAWY Z 3 KLASTRÓW

— które, od kiedy

CZY OBJAWY BYŁY OBECNE PRZED 12 R.Ż.

— wspomnienia ze szkoły, opinie rodziców

Klucz: Wilens i wsp. (2011, n=2 165): u pacjentów z uzależnieniem + ADHD, **leczone ADHD** jest jednym z najsilniejszych predyktorów utrzymania abstynencji w 12 mies. (HR 0,45). Mechanizm: mózg ADHD bez leczenia wciąż „szuka stymulacji” — co staje się stałym wyzwalaczem nawrotu. Z drugiej strony: **diagnoza ADHD nie powinna być narzucana**, ani „wytłumaczeniem” uzależnienia. To dwie różne diagnozy, które się przecinają i wymagają osobnego leczenia w sposób zintegrowany. W Polsce ośrodki diagnostyczne ADHD u dorosłych są w większych miastach — kolejki długie, prywatnie 800–1500 zł za pełną diagnozę.